

35-1. 음주 상담

• 중요성 (rationale)

- 과다 음주는 개인의 건강에 피해를 줄 뿐만 아니라 심각한 가정적, 사회적 문제가 됨.
- 음주로 인한 여러 문제를 파악하고 그에 따른 적절한 대책을 강구하는 것이 중요

• 평가 목표

원인		
위험음주		위험음주
알코올사용장애		알코올사용장애
평가목표		
1) 음주 정도와 이로 인한 건강문제, 사회/가정적 문제를 평가		
2) 금주에 도움이 되는 환자 교육과 조치를 시행		
구체적인 성과		
병력 청취	음주로 인한 건강위험도와 병적상태를 평가	소화기 증상: 복통(궤장염 의심), 오심, 구토, 토혈, 설사. 기저 질환: 고혈압, 당뇨, 간질환(지방간, 간경변), 통풍 여부. 과거력: 알코올성 간염, 위궤양 진단 이력.
	음주 습관을 평가	음주 빈도 및 양: 일주일 평균 음주 횟수, 한 번 마실 때의 양(표준 잔 기준). 주종 및 패턴: 선호하는 술의 종류, 폭음 여부, 혼자 먹는지
	알코올 의존 및 남용 정도를 평가	내성: 이전과 같은 효과를 얻기 위해 술의 양이 늘었는지 확인. 금단 증상: 술을 끊었을 때 손떨림, 식은땀, 환청, 불면 등이 나타나는지 확인.
	음주로 인한 가정 및 심리사회적인 문제를 평가	대인 관계: 음주로 인한 가족 및 친구와의 갈등, 폭력 행사 여부. 사회적 기능: 무단결근, 업무 능력 저하, 음주운전 등 법적 문제 유무. 심리 상태: 음주 후 우울감, 죄책감, 자살 사고 유무.
	금주 방해요인이나 실패요인	환경: 술 권하는 직장 문화, 주변의 음주 친구들. 심리적 요인: 스트레스 해소 수단 부재, 외로움, 불면증.
신체 진찰	음주와 관련된 신체진찰	활력 징후: 혈압 상승, 빈맥 확인. 복부 진찰: 간비대, 압통, 복수 확인. 피부 징후: 황달, 거미혈관종(Spider angioma), 수장홍반(Palmar erythema). 신경계 진찰: 손떨림, 보행 이상, 안구 운동 장애(Wernicke 의심).
진단	알코올 의존 정도 파악	AUDIT-K (알코올 사용장애 선별검사): 한국형 표준 검사 도구 활용. CAGE 설문: (Cut down, Annoyed, Guilty, Eye-opener) 간단한 선별.
	신체적 상태 파악	혈액 검사: 간수치(AST/ALT/GGT), 중성지방 수치. 영상 검사: 복부 초음파 또는 CT 를 통한 간 섬유화 및 궤장 확인.
	정신적 상태 파악	우울/불안 척도, 인지 기능 검사
	금주에 도움이 되는 약물과 처치, 행동 요령	급성 금단 조치: 벤조디아제핀 처방으로 경련 및 섬망 예방, 티아민(비타민 B1) 투여로 베르니케 뇌병증 예방. 항갈망제 처방: 날트렉손(음주 쾌감 억제), 아캄프로세이트(금단 불쾌감 완화). 혐오 요법: 디설피람 고려
환자 교육	음주의 피해와 금연의 이득 설명	피해: 간암, 궤장염, 알코올성 치매, 심근병증 위험 설명. 이득: 간 기능 회복, 깊은 수면 유도, 경제적 이득, 대인관계 개선.
	약물 및 행동 요령 교육	약물 교육: 항갈망제는 의존성이 없으며 꾸준히 복용해야 효과적임을 강조. HALT 원칙: 배고픔(Hungry), 분노(Angry), 외로움(Lonely), 피로(Tired)할 때 술을 찾게 되므로 이 상태를 피하도록 교육. 자조 모임 안내: AA 모임 연계 및 지역사회 중독관리통합지원센터 안내.
7-가. 면담 시 환자의 태도에 따라 설득력 있게 교육을 할 수 있다.		

	남용과 의존 항목에서 1 개: 정상 2~3 개: 중증도 알코올 사용장애 4 개 이상: 중증 알코올 사용장애	- 아니오 (0 점) 0~3 점: 낮은 의존(행동요법 주로 시행, 방해요인 대책) 4~6 점: 중증도(약물 요법 추천) 7 점 이상: 높은 의존(약물 요법 강력 권장)
남용	법의학연신 [법적] 술/담배와 관련된 법적 문제가 있었나요? [의무] 술/담배 때문에 지각, 결근을 하거나 중요한 할 일을 못하진 않았나요? [관계] 술/담배로 인해서 대인 관계가 나빠지지는 않았나요? [여가] 술/담배로 여가 활동 시간을 포기하게 되나요? [신체] 술/담배로 인해 스스로를 다치게 하거나 병들게 한 적이 있나요?	
시도	이전에 금주/금연을 시도해 본적 있나요? 얼마나 오래 금주/금연하셨나요? 실패했던 이유는 무엇이라고 생각하세요? 주로 금주/금연을 방해하는 요소는 어떤 것이 있을까요?	
금단	금주했을 당시에 어떤 금단 증상이 있었나요? 불안/우울/불면/두근거림/손떨림/식은땀/메스꺼움/구토/환청/환시/경련	금연했을 당시에 어떤 금단 증상이 있었나요? 불안/우울/불면/두근거림/짜증/식욕 증가/체중 증가
A	[전신] 발열/오한/체중변화/피로 [소화기] 식욕변화/오심/구토/설사/복통/혈변/토혈/소화불량/속쓰림 [알코올성 기본장애] 우울/의욕 저하 [알코올성 불안장애] 과도하게 걱정하거나 불안하세요? [알코올성 기억장애] 기억력에 문제가 있나요? 필름이 끊긴 적이 있나요?	[전신] 발열/오한/체중변화/피로 [호흡기] 기침/가래/호흡곤란/흉통/쌔쌔거림/객혈/최근 감기 [구강] 치아변색/구강내종양
E	건강 검진에서 이상이 있었나요?	
외	입원하거나 수술한 적 있나요?	
과	HTN/DM/고지혈증/심장질환/호흡기질환/정신과 치료	
약	복용중인 약물	
사	음주/흡연/직업/스트레스/식습관/운동	
가	가족 중에 간/폐질환, 술/담배 문제	
PEx	동의 구하기 손 씻기 V/S 확인 (혈압, 맥박, 호흡수, 체온) 1 G/A: 의식/정신 상태, 전반적인 위생, 영양 상태 2 눈: 빈혈, 황달, 안구진탕 3 입: 탈수, 치아 변색, 구강 내 종양 4 손: 손바닥 angioma + flapping tremor 5 흉부: 심장 청진, 호흡음 청진 6 복부: 시정타촉 + 간, 복수	
진단 검사	지금까지의 문진을 종합해 보았을 때 환자 분께서는 현재 알코올에 대한 의존도가 중증으로 매우 높은 알코올 사용장애가 의심이 됩니다. 또한 현재 소화불량 등의 증상이 오래된 것으로 보아 음주로 인해서 소화기에 문제가 생겼을 가능성이 있습니다. 이에 대해서 추가적으로 간기능 검사와 복부 초음파를 해보는 것이 좋을 것 같습니다. 괜찮으신가요?	지금까지의 문진을 종합해 보았을 때 환자분께서는 현재 니코틴의 의존도가 상당히 높은 것으로 확인되었습니다. 또한 현재 기침이나 가래 등의 증상이 오래된 것으로 보아 흡연으로 인해서 호흡기에 문제가 생겼을 가능성이 있습니다. 이에 대해서는 추가적으로 가슴 X-ray와 폐기능검사를 해보는 것이 좋을 것 같습니다. 괜찮으신가요?
[설득] Risk	술을 드시면 어떤 점이 위험한 지 알고 계신 것이 있나요? [설명] 네, 잘 알고 계시는군요. 환자 분께서 아시고 계시는 것처럼 술을 너무 많이 마시면 간에 무리가 갈 수 있고, 간염과 간경변이 발생할 수 있습니다. 식도와 위에도 염증을 일으키고, 고혈압과 뇌출혈이 더 잘 생길 수 있습니다.	흡연을 하시면 어떤 점이 위험한지 알고 계신 것이 있나요? [설명] 기본적으로 폐암을 유발할 수 있으며, 협심증, 심근경색을 포함한 심혈관계 질환 및 위궤양, 역류성 식도염을 일으킬 수 있습니다.

		[부가 설명] 정자 및 성기능 저하, 입냄새 및 누런 치아, 피부가 푸석해지고 탈모가 일어날 수 있으며, 골다공증도 유발, *임신 예정 : 태아의 호흡기 및 알레르기 질환을 유발
[설득] Reward	금주를 하면 어떤 좋은 점이 있는지 알고 계시나요? [설명] 네, 그것과 더불어서 앞서 말씀드렸던 질환이 생길 확률이 줄어드는 것은 물론, 환자분의 신체 활동 능력 자체가 전반적으로 향상될 수 있습니다. 또한 술 한 병이 이전원 정도 한다고 생각한다면 매일 두 병만 마셔도 한 달에 12만원인데, 이 돈으로 할 수 있는 것도 참 많을 것이라 생각이 듭니다.	금연을 하면 어떤 좋은 점이 있는지 알고 계 시나요? [설명] 네, 그것과 더불어서 만성질환 및 심뇌혈관 질환이 생길 확률이 줄어드는 것은 물론, 환자분의 신체 활동 능력 자체가 전반적으로 향상될 수 있습니다. 담배 한 갑에 5,000 원이라고 잡는다면 하루 한 갑을 피는 경우 한 달에 15 만원 절약이 가능합니다. 15 만원이면 무엇을 할 수 있는지 생각해 보시는 것도 좋을 것 같습니다.
격려 조력	그래도 이렇게 스스로 결심해서 병원을 찾은 것을 보면 의지가 굉장히 강하신 것 같아서 금주/금연을 꼭 성공하실 수 있을 것 같습니다. 술/담배를 단번에 끊기 보다는 점차 음주/흡연 횟수나 양을 줄이는 목표를 갖는 것이 좋을 것 같습니다. 금주/금연을 하게 된다면 주변에서 환자분을 도와줄 사람이 있나요? 방해되는 사람은 있나요? 주변에서 그 분들과 함께하면 도움이 극대화되므로 그분들도 이번 기회에 설득해서 같이 금주/금연을 하는 것이 금연 성공률을 더 높일 수 있을 것 같습니다.	
전략	그러면 언제부터 금주/금연을 하기로 정할까요? (1 ~2 주 내 특별한 날)	
	금주를 위해서 주변에 금주 사실을 알리시는 게 좋습니다. 술자리는 가급적 피하세요. 금주를 위해 단주 동맹이나 알코올 자조 단체가 있으니 함께 참여하시거나 음주일기를 쓰시면 금주에 큰 도움이 될 것입니다. 술 생각이 간절해지는 순간을 미리 파악하는 것이 중요합니다. 보통 H(배고플 때), A(화날 때), L(외로울 때), T(피곤할 때) 술을 찾게 됩니다. 이럴 땐 술잔을 들기 전에 먼저 물 한 잔을 마시거나, 가벼운 간식을 드시거나, 10 분만 산책하며 주의를 돌려보세요. 그 10 분만 잘 넘기면 갈망은 파도처럼 지나갑니다.	주변에 금연을 하기로 한 것을 많이 알리시는 것이 좋습니다. 담배, 라이터, 재떨이 등 흡연에 필요한 물품들은 다 버리세요. 한동안은 술 자리를 피하는 것이 금연하는 것에 도움이 되실 것입니다. 담배가 간절히 생각날 때는 딱 5 분 만 버티면 갈망이 줄어듭니다. 다음 4 가지를 기억하세요. Delay (지연하기), Deep breathing (심호흡), Drink water (물 마시기), Distract (관심 돌리기)
금단, 대처	금단 증상은 2~3 일째 가장 심하고, 이때 손떨림, 불면증, 메스꺼움, 구토, 환청, 환시, 경련, 불안, 식은땀, 두근거림 같은 증상들이 나타날 수 있습니다. 금단 증상이 심할 때에는 완화시켜 줄 수 있는 신경안정제 벤조디아제핀을 오늘 처방해 드릴테니, 드시기 바랍니다. 또한 술에 대한 조절력 상실은 도덕적인 문제가 아니고 생물학적인 문제이기 때문에 약물 치료가 필요할 수 있습니다. 약물보조요법으로 몇 가지 약물을 처방해 드리겠습니다. 우리가 처방해 드리는 항갈망제 는 술을 마시고 싶은 충동 자체를 줄여주는 역할을 합니다. 의존성이 없는 안전한 약이니, 이 도구를 잘 활용해서 더 편하게 목표를 달성해 봅시다. *항갈망제: Naltrexone, Acamprostate 등	금연을 하게 되면 2~3 일 정도에 금단 증상이 가장 심하게 나타날텐데, 5 일 정도 지나면 증상이 감소하기 때문에 이때 군것질거리나 손장난거리를 정해서서 잘 이겨 내시는 것이 중요할 것 같습니다. 또한 적절한 운동을 해주시는 것도 도움이 되실 것입니다. 만약 스스로의 힘으로 어렵다면 약물요법을 추가적으로 시행할 수 있습니다. 약물 치료를 병행하면 금연 성공률이 몇 배 이상 높아집니다. 처방해 드리는 약(바레니클린 등)은 뇌에서 담배 맛을 없게 만들고 금단 증상을 줄여주는 안전한 약 입니다. *니코틴 패치, 부프로피온, 바레니클린 속 메스꺼움 (m/c), 소화불량 발생 가능, 3 개월 이상 복용 경련 과거력 : 부프로피온 X 협심증 등 심혈관 질환, 소화성궤양 : 니코틴 패치 X
약속	1 ~2 주 후에 다시 한 번 외래에 방문하셔서 그 동안 어떤 것이 힘들었는지 어떻게 잘 지켜왔는지 확인하고 그에 따라서 조절해보도록 하겠습니다. 또한 신체적, 정신적으로 많이 힘이 드실 때는 언제든지 찾아오셔도 좋습니다. 1 주일 뒤에 예약해 드려도 괜찮을까요? 네, 그럼 그때 뵙겠습니다.	
PPI	궁금하신 점 있으실까요?	

거절한다면-> 담배를 끊는 걸 망설이시는 이유가 있을까요? 네, 지금까지 오랜 시간 피던 담배를 갑자기 끊는게 쉬운 일은 아니리라 생각합니다. 하지만 지금 OOO 님이 겪고 계신 문제는 담배를 끊고 계시면 해결되지 않을 가능성이 높습니다. 저희와 함께 담배를 끊기 위한 치료를 받아보는게 어떨까요?

가능성은 낮지만 2-3 번 물어도 금연 의사가 없다고 답할 경우, 언제든 상담을 받을 수 있고 담배는 일찍 끊을수록 좋다는 것을 강조하며 교육을 마무리한다.